Grundkoncept för patientstyrd sedering utan anestesipersonal, OP/IVA-klinikerna

Inledning

Propofol är ett kortverkande, intravenöst anestesimedel som används dagligen på anestesikliniker för att inducera och underhålla narkos eller sedering. Vid patientstyrd sedering (PSS) ges läkemedlet i små, kontrollerade doser via en knapptryckning som patienten själv styr. Det ger en individanpassad sedering under olika procedurer utanför operationssal. Detta ökar patientens upplevelse av trygghet och kontroll samtidigt som det minskar behovet av djup narkos.

Konceptet syftar till att skapa ett enhetligt och säkert arbetssätt för enheter inom Region Jönköpings län, så att PSS vid elektiva interventioner kan genomföras strukturerat, tryggt och patientsäkert. Då sedering med anestesimedel som Propofol kan medföra risk för andnings- och cirkulationsdepression ställs höga krav på övervakning och beredskap. Patienten övervakas av legitimerad sjuksköterska som har reell klinisk kompetens att tolka och snabbt åtgärda avvikelser under sedering och uppvaknande. Ansvarig för ingreppet/undersökningen ska ha reell klinisk kompetens att inför sedering adekvat värdera patientens hälsotillstånd.

Patienturval

- Vuxna 16 år
- ASA 1–2
- BMI <40

Gravida kvinnor bör undvikas men vid behov okej v. 12-22 , innan v. 12 kontakt med gynekolog.

Ej lämpligt för:

- Patienter med kommunikationssvårigheter
- Allergi mot Propofol
- Svåra refluxsymtom (kan inte ligga plant trots behandling)
- Svåra svälnjningsbesvär, akalasi
- Gapbesvär (kan inte gapa hos tandläkare)
- Patienter med sömnapné (behandlingskrävande)
- Patienter med svår luftväg (missbildningar/stor tunga/tid narkosproblem)
- Nackbesvär (extension/flektion)

Förberedelser

- Patienten ska vara fastande enligt SFAI:s riktlinjer
- Hälsodeklaration värderad (eller enligt lokalrutin) och checklista kontrollerad före start
- Patienten informeras om proceduren
- Narkosläkare kontaktas före start
- Utrustning kontrolleras enligt lista nedan

Läkemedel

Propofol 10 mg/ml till sprutpumpen

Atropin 0,5 mg/ml, vid låg hjärtfrekvens HR < 40 slag/minut

Utrustning

- Pulsoximeter
- Blodtrycksmätare
- EKG (valfritt beroende på lokal rutin)
- Syrgas och syrgasutrustning (inkl grimma/mask)
- Sug och sugutrustning
- Andningsblåsa med syrgas reservoar
- Nästuber, storlek 26-30
- Svalgtuber storlek 3 och 4
- Läkemedel

Tillvägagångssätt

1. Kontrollera sugutrustning och kontakta narkosläkare (första patient).
2. Läkemedel enligt generell ordination. Propofol 10 mg/ml dras upp i en 20 ml spruta av patientansvarig sjuksköterska och monteras i PSS-pumpen. PSS-pumpen skall vara inställd på 5 mg/bolus och 6-8 ggr/minut. Atropin 0,5 mg ska finnas tillgänglig och ges vid HF < 40 slag/minut.
3. Uppkoppling till övervakning: SpO2, blodtrycksmanschett och EKG (beroende på rutin) Blodtryck var 5:e minut, SaO2 och AF var 15:e minut.
4. Syrgasgrimma/mask kopplas 1-4 l/minut om SpO2 < 93%.
5. PVK, ej samma arm som NIBP.
6. Start av proceduren. Patienten uppmanas att trycka upprepade gånger tills upplevd påverkan nås. Endast patienten får trycka på knappen. Målnivån för sederingen är enligt Ramsayskalan 2-3.

Sederingsskala enligt Ramsay

Nivå 1: Klarvaken

Nivå 2: Dåsig, lätt sederad

Nivå 3: Sederad, men väckbar genom normal samtalston

Nivå 4: Sederad, men väckbar genom höjd samtalston eller kraftig omruskning

Nivå 5: Medvetslös, svara ej på fysisk stimulering (=anestesi)

Dokumentation

- Dokumentation av vitala parametrar, BT var 5:e minut, SaO2 och AF var 15:e minut.
- Cosmicmall ersätter checklista, där Cosmic används.
- Läkemedel dokumenteras i läkemedelsmodulen.

Efter sederingen

- Patienten observeras i minst 30 minuter efter avslutad sedering
- Utskrivningskriterier: fullt vaken och mobiliserad
- Patienten får inte köra bil samma dag

Ansvarsfördelning

- Ansvarig läkare (gynekolog, kirurg eller skopist) bedömer patientens lämplighet för PSS och ansvarar för medicinsk säkerhet under ingreppet.
- Ansvarig sjuksköterska ansvarar för övervakning och dokumentation under sedering och uppvaknande.
- Alla i teamet har skyldighet att kunna larma vid avvikelser eller komplikationer.
- Anestesiolog ska kontaktas före sederingsstart och vara tillgänglig vid behov.
- Klinikerna ansvarar för att medarbetarna deltar i årlig träff, repetitionsutbildning i fria luftvägar och utvärdering av PSS.